Adaptations scolaires

Stratégies d'enseignement et aménagements concrets

Ajustements concrets selon les disciplines

📖 Langues (arabe, français, anglais)

- Alléger la charge visuelle : agrandir la police (Arial 14 ou 16), aérer la mise en page, utiliser un cache pour masquer les lignes non lues.
- Faciliter la compréhension : lire les consignes à voix haute, surligner les mots-clés, reformuler avec des phrases simples.
- Évaluer davantage la compréhension que la vitesse
- Accorder plus de temps pour la copie
- Répétition et rituels : les langues nécessitent de la mémoire ; privilégier des rituels quotidiens courts (comptines, questions-réponses simples).
- Alléger l'écrit : en production écrite, accepter des phrases simples, utiliser des modèles à trous.
- Favoriser l'oral : évaluer surtout la compréhension et l'expression orale si l'écrit est trop coûteux.

🔢 Mathématiques

- Rendre l'abstrait concret : utiliser du matériel manipulable (jetons, réglettes, cubes) avant de passer aux symboles.
- Fractionner les exercices : proposer des séquences courtes avec des pauses (ex. "fais les trois premiers, on vérifie, puis on continue").
- Alléger la mémorisation : autoriser un aide-mémoire (table de multiplication, formules) scotché sur la table – ce n'est pas de la triche, c'est compenser une difficulté.
- Valoriser le raisonnement : dans les problèmes, noter la démarche même si le résultat final est erroné.

🏃♂️ Éducation physique (EPS)

✔**Ne pas exclure systématiquement :** l'EPS est bénéfique pour la santé et l'intégration. Adapter, pas exclure.

✔**Proposer des alternatives** : si l'élève ne peut pas participer à une activité, lui confier un rôle d'arbitre, de chronométreur, ou un travail sur les règles.

✔ Éviter les activités en hauteur (gradins, escalade improvisée)

✔ Prévoir une surveillance rapprochée

✔ Autoriser des pauses supplémentaires

L'élève peut participer normalement sauf indication médicale contraire.

🎨 Arts et activités créatives

Ces matières sont souvent un espace de valorisation.

✔ Encourager la participation

✔ Mettre en avant les réussites

✔ Favoriser l'expression et la confiance

Évaluations adaptées

Principe général : L'objectif n'est pas de diminuer le niveau d'exigence, mais de contourner les obstacles liés à la pathologie pour évaluer les réelles compétences de l'élève.

Adaptations concrètes pour les évaluations

A. Avant l'évaluation

- **Prévenir en amont :** Annoncer clairement la date et le contenu. La surprise est source de stress, facteur déclenchant de crises.
- Vérifier la compréhension des consignes : S'assurer que l'élève a bien compris ce qui est attendu (reformuler, faire reformuler).
- **Adapter la forme :**
  - Police de caractère plus grande, aérée.
  - Une seule consigne par question.
  - Éviter les items trop longs ou denses visuellement.

B. Pendant l'évaluation

- **Tiers-temps :** Accorder un temps supplémentaire (souvent 1/3 temps supplémentaire). C'est l'aménagement le plus courant, préconisé dans le PAI ou le PPS.
- **Salle au calme :** Si possible, proposer une évaluation dans un lieu avec moins de stimuli (bruit, mouvement) pour favoriser la concentration.
- **Autoriser les pauses :** L'élève peut avoir besoin de lever la tête, fermer les yeux 30 secondes, ou boire un peu d'eau pour "repartir".
- **Dicter à un adulte :** Pour les élèves ayant des difficultés graphiques liées aux médicaments (tremblements) ou une lenteur d'écriture, l'évaluation orale peut être pertinente.

C. Adapter l'évaluation elle-même

- **Privilégier la compétence :** Si l'objectif est d'évaluer la compréhension d'un problème mathématique, pourquoi pénaliser la présentation ou les fautes d'orthographe ?
- **Questions à choix multiples (QCM)** : Peut être plus simple qu'une question rédactionnelle pour un élève ayant des difficultés d'évocation.
- **Barème adapté :** Valoriser le raisonnement, pas seulement le résultat final.

Important : Tous ces aménagements doivent être discutés avec la famille et le médecin scolaire, et idéalement formalisés dans un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) ou un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) .

Gestion du groupe classe

Objectif : Créer un climat de confiance et de sécurité pour l'élève épileptique ET pour ses camarades.

1. Informer ou ne pas informer la classe ?

C'est la question la plus délicate. Tout dépend de la volonté de l'élève et de sa famille.

- Si l'élève est d'accord : Une information simple et positive peut démystifier la maladie et éviter les moqueries ou la peur.
- Si l'élève ne souhaite pas que sa maladie soit divulguée : Il faut respecter ce choix (secret médical). On peut alors parler de "problème de santé" sans entrer dans les détails.

2. Comment préparer la classe ? (Si information partagée)

A. Avant toute chose :

- Obtenir l'accord écrit de la famille et de l'élève.
- Proposer à l'élève d'être présent ou non lors de l'explication (souvent, il préfère ne pas être là).

B. Le discours à tenir :

- Dédramatiser : Expliquer que c'est une maladie comme une autre (comme l'asthme ou le diabète). Insister sur le fait que ce n'est pas contagieux.
- Expliquer simplement : "Parfois, le cerveau de [Prénom] envoie des signaux trop forts, comme un petit orage électrique. Cela peut lui faire faire des choses bizarres, mais il ne souffre pas et il ne le fait pas exprès."
- Donner un rôle aux élèves : "Si ça arrive, le plus important c'est de rester calme, de ne pas crier, et de laisser faire l'adulte. Vous pouvez aider en éloignant les chaises ou en allant chercher un autre adulte si on vous le demande."

3. Gérer le retour après une crise

- Accueillir l'élève à son retour (souvent après un passage à l'infirmerie) simplement : "Tu vas bien ? On a travaillé sur telle chose, tu pourras rattraper tranquillement."
- Parler au groupe : " [Prénom] va bien, il est fatigué, on continue la journée normalement."
- Ne pas faire de commentaires : Éviter de reparler de la crise sans fin. L'élève peut avoir honte ou être gêné. La normalité est la meilleure des thérapies.

4. Prévenir l'isolement

- Activités de groupe : Favoriser les travaux de groupe (en surveillant discrètement que l'élève soit inclus).
- Attention aux absences : L'élève épileptique peut être plus souvent absent (rendez-vous médicaux, fatigue). Proposer un système de tutorat ou donner les cours à rattraper sans faire peser la charge sur lui seul.
- Lutter contre la surprotection : Le traiter comme les autres (sauf consigne médicale contraire). L'autonomie est essentielle à sa construction.